

يُسبب مرض بيروني تكوّن ندبة (لويحة) داخل القضيبي تحدث أثناء الانتصاب، مما قد يُعسر الجماع. في هذه الجراحة، تُشقّ الندبة على الجانب المنقبض القصير (وتُستأصل جزئياً أحياناً) لتحرير الانحناء، ثم يُسدّ الفراغ بطعم (graft). تشرح هذه النشرة آلية العملية وكيفية التحضير لها وما ينبغي توقّعه.

عن هذا الإجراء

تشدّ لويحة الندبة أحد جانبي القضيبي فيظهر الانحناء لدى الانتصاب. تُعالج هذه العملية الانحناء بشقّ الندبة على الجانب القصير (الداخلي)؛ ينشأ فراغ يُملأ بطعم (graft) — رقعة رقيقة (مثل رقعة كولاجين أو نسيج متبرّع به أو نسيج من جسمك). إذ يُطيل الجانب القصير بدلاً من تقصير الجانب الطويل، فيُحافظ بذلك على طول القضيبي.

يُلبأ إليها عندما:

- كان الانحناء شديداً أو معقداً (مثل الشكل الساعي الرملي أو ظاهرة التمثصل)
- كان الحفاظ على الطول أمراً مهماً (إذ سيُقصّر التثنية كثيراً)
- كانت الانتصابات قوية بما يكفي لتحمل هذه الجراحة

ما ينبغي معرفته

الميزة هي الحفاظ على الطول (بل وزيادته أحياناً). المقايضة هي احتمال أعلى للإصابة بمشاكل الانتصاب مقارنةً بالتثنية — لأن العمل على الندبة قد يؤثر في احتجاز الدم — لذا لا تُجرى إلا عند الانتصاب القوي. خدر حشفة القضيبي شائع في البداية (إذ تُرفع الأعصاب بلطف خلال الجراحة) وعادةً ما يتعافى خلال 6-12 شهراً. يحصل معظم المرضى على انتصاب مستقيم يُمكن من الجماع.

تعلم المصطلحات

مرض بيروني

ندبة داخل القضيبي تُسبب انحناءه أثناء الانتصاب.

اللويحة

منطقة الندبة المسببة للانحناء.

الطعم (Graft)

رقعة رقيقة تملأ الفراغ بعد تحرير الندبة — قد تكون رقعة كولاجين أو نسيجاً متبرّعاً به أو نسيجاً من جسمك.

الانتصاب الاصطناعي

انتصاب يُحدث في غرفة العمليات بحقنة ليقيس الجراح الانحناء ويتحقق منه.

ختان القلفة

إزالة القلفة — تُجرى في الغالب في الوقت ذاته إن لم تكن مختوناً.

إعادة التأهيل القضيبي

استخدام حبة انتصاب و/أو جهاز شفط خلال فترة الشفاء لحماية الانتصاب والطول.

التخدير العام

دواء يُفقدك نائماً بلا ألم طوال العملية.

هل سيؤلم؟ تُجرى العملية تحت التخدير العام أو النخاعي فلا تشعر بشيء خلالها. بعدها، توقّع تورماً وكدمات وألماً في القضيب لمدة 1-2 أسبوع — تُساعد الثلج والدعامة والمسكنات. تستغرق هذه الجراحة وقتاً أطول من التئمة (1.5-3 ساعات غالباً)، وقد تحتاج إلى المبيت ليلة واحدة. تُوضع قسرة عادةً وتُزال صباح اليوم التالي.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

- تُجرى تحت التخدير العام أو النخاعي — اتّبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام وإيقاف الأدوية بما فيها مرقّقات الدم).
- يجب أن يكون مريض بيروني مستقراً (تنبّث الانحناء والألم لأشهر)، وتُفحص الانتصابات قبل الجراحة — إذ تتطلب هذه العملية وظيفة انتصابية جيدة.
- امتنع عن التدخين؛ تُعالج أي عدوى أولاً وتُعطى مضادات حيوية. إن لم تكن مختوناً، يُجرى الختان عادةً في الوقت ذاته.

أخبر فريقك مسبقاً إذا:

- كانت انتصابتك ضعيفة أو تحتاج لأدوية أو حقن للانتصاب
- تتناول مرقّق دم أو خضعت لجراحة سابقة في القضيب

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 تكون نائماً أو مخدراً؛ تُعطى مضادات حيوية.
- 2 يُحدث انتصاب بحقنة لإظهار الانحناء؛ تُرفع الجلدة وتُنخى الأعصاب فوق القضيب بلطف.
- 3 تُشق الندبة على الجانب القصير (وتُستأصل جزئياً أحياناً) لتحرير الانحناء، ويُسدّ الفراغ بطعم؛ تُفحص النتيجة ثم تُغلق الجلدة.

بعد الجراحة

- توقّع تورماً وكدمات وألماً لمدة 1-2 أسبوع. خدر حشفة القضيب شائع ويتعافى عادةً خلال أشهر.
- تُزال القسرة في الغالب صباح اليوم التالي.
- تجنّب الجماع لنحو 6-8 أسابيع لإتاحة الوقت للطعم كي يلتئم.
- سيُرشّح فريقك على الأرجح إعادة التأهيل القضبي — حبة انتصاب بجرعة منخفضة و/أو جهاز شقّ يومي — لحماية الانتصاب والطول.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة، أو احمرار وألم وتورم أو إفراز متزايد من الجرح
- عجز عن التبوّل
- تورم أو ألم شديد متصاعد، أو نزيف غزير

ثلاثة أمور تذكّرنا

1. تُعالج هذه الجراحة الانحناء بشقّ الندبة على الجانب القصير وسدّ الفراغ بطعم — تحافظ على الطول وتُستخدم للانحناءات الشديدة أو المعقدة.
2. المقايضة هي احتمال أعلى لمشاكل الانتصاب مقارنةً بالتئمة، لذا لا تُجرى إلا عند الانتصاب القوي؛ خدر الحشفة المبكر شائع وعادةً ما يتعافى.
3. يجب أن يكون المريض مستقراً وتُفحص الانتصابات أولاً؛ امتنع عن التدخين. بعد الجراحة، تجنّب الجماع ~6-8 أسابيع واتّبع برنامج إعادة التأهيل. اتصل عند الحمى أو التورم الشديد أو صعوبة التبوّل.